



RESUMO DE AULA · JORNADA DA LEITURA

Impactos do desempenho do terapeuta

CAPÍTULO 2

*O terapeuta é, ele próprio, um fator de desfecho — e as habilidades interpessoais que
fazem diferença podem ser desenvolvidas.*

Lógica Psicológica

Prática Baseada em Evidências na Psicologia

PROFESSOR E PSICÓLOGO CLÍNICO

Júlio Gonçalves

MSC · CRP 12/17614

Aprenda muito mais na

COMUNIDADE LÓGICA PSICOLÓGICA

UMA COMUNIDADE PARA QUEM QUER:

- Ψ **Aprofundar o raciocínio clínico** com conteúdos que unem ciência, processos e análise funcional para decisões mais precisas.
- Ψ **Estruturar uma prática ética e coerente**, baseada em pensamento crítico, clareza conceitual e evidências atualizadas.
- Ψ **Desenvolver o self clínico** por meio de supervisão, leituras guiadas, atualizações científicas e construção em rede.

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS



O ESSENCIAL

- Ψ **O terapeuta é, ele próprio, um fator de desfecho.** Quem conduz — e não só a técnica aplicada — influencia o resultado. A relação é ferramenta de tratamento, usada com intenção do primeiro contato ao encerramento.
- Ψ **Entre as variáveis do terapeuta, as habilidades interpessoais são o preditor mais robusto** de bons resultados — acima da orientação teórica e até da área de formação.
- Ψ **Essas habilidades podem ser desenvolvidas:** autoanálise, feedback, gravação de sessões e supervisão sobre o *como* intervir.
- Ψ **Comportamento difícil do paciente é dado clínico, não ofensa pessoal.** Ler assim preserva a empatia e sustenta os limites.
- Ψ **Chef e ingredientes:** relação e técnica são necessárias juntas — nenhuma substitui a outra.

O TERAPEUTA COMO FATOR DE DESFECHO

O ciclo abriu desfazendo um mal-entendido comum: gostar do paciente e ser gentil não substitui competência. A relação terapêutica é um **fator comum** de desfecho — está entre os elementos que explicam melhora *através* das diferentes abordagens — e por isso deve ser tratada como instrumento de trabalho, não como pano de fundo simpático.

O respaldo vem da pesquisa sobre **efeitos do terapeuta**: quando se comparam profissionais entre si, as diferenças de resultado entre eles são reais e clinicamente relevantes. A ideia de que há fatores comuns operando por baixo das abordagens é antiga — remonta a Rosenzweig (1936) —, mas a novidade das últimas décadas foi conseguir *medir* variáveis do terapeuta e ligá-las ao desfecho.

HABILIDADES INTERPESSOAIS: O PREDITOR MAIS ROBUSTO

Entre as variáveis do terapeuta, as **habilidades interpessoais** (empatia, calor, capacidade de vínculo) aparecem como o preditor mais consistente de bons resultados. **Anderson e colaboradores (2009)** mostraram, com a tarefa de *Facilitative Interpersonal Skills* (FIS), que elas previam o desfecho melhor do que outras variáveis do terapeuta e do paciente.

O estudo citado na aula (os "23 de áreas diversas") torna isso mais impressionante: em um ensaio, **Anderson et al. (2016)** compararam terapeutas em formação em psicologia clínica com doutorandos de outras áreas — biologia, química, história, comunicação. As diferenças de desfecho entre os grupos treinado e não treinado foram desprezíveis; o que produziu melhores resultados foi o **nível de base de habilidade interpessoal** — mais até do que a área de formação.

CALIBRAGEM

Isso não diz que técnica e formação são irrelevantes, nem que qualquer pessoa carismática seria boa terapeuta. Diz que a habilidade interpessoal é uma condição de base poderosa — e mensurável — sobre a qual o resto se constrói.

ESSAS HABILIDADES PODEM SER DESENVOLVIDAS

O corolário prático — e a razão de o ciclo existir — é que esse "fator terapeuta" é treinável. A aula reuniu caminhos concretos:

Ψ **Autoanálise** honesta do próprio estilo.

Ψ **Feedback** das pessoas atendidas.

Ψ **Gravar sessões** (com autorização) para se rever — e usar IA como apoio na análise de casos.

Ψ **Supervisão sobre o "como"** intervir, não só o "o que" fazer.

Dois cuidados moderam o entusiasmo: **não perseguir perfeição e respeitar os limites da própria personalidade** — há competências que se lapidam e traços que se administram, e reconhecer a diferença evita autocobrança estéril.

ESCUTA E COMUNICAÇÃO NA SESSÃO

No nível das micro-habilidades, o encontro destacou práticas de escuta que sustentam a relação:

Ψ **Tolerar o silêncio** em vez de preenchê-lo por ansiedade — difícil sobretudo com adolescentes, e um convite a romper com o "psicólogo-parede".

Ψ **Questionamento socrático** no lugar de interpretações apressadas.

Ψ **Resumir a fala** da pessoa antes de interpretar, conferindo se a leitura faz sentido para ela.

Ψ **Adaptar a comunicação** ao perfil de cada um: menos tecnicismo, mais metáforas e exemplos.

QUANDO O PACIENTE DIFICULTA: COMPORTAMENTO COMO DADO CLÍNICO

Nem sempre dá para exercer essas habilidades com fluidez — resistência, busca de controle, recusa em fazer planos de ação, omissão e mesmo manipulação aparecem e travam a relação. O deslocamento central proposto na aula é ler esses comportamentos como **dado clínico**, não como afronta pessoal. Mesmo quando o terapeuta se sente lesado, a postura é de leitura técnica do que está acontecendo, preservando a empatia.

O mesmo vale para o manejo de linguagem: um relato do grupo, sobre atender pessoas recém-divorciadas, ilustrou como **transformar termos pejorativos em linguagem técnica** — o que sustenta o respeito e a integridade da relação — mantendo, ao mesmo tempo, limites profissionais, sem escorregar para a "pena".

LIMITES, COMPATIBILIDADE E ENCAMINHAMENTO ÉTICO

Um ponto sóbrio fechou a discussão: **nem todo terapeuta é eficaz com todo paciente**. Identificar os próprios déficits não é fracasso — é o que permite encaminhar, em benefício de quem procura ajuda.

O encaminhamento é apresentado como **ato ético** quando falta a habilidade técnica necessária (por exemplo, casos de violência doméstica, ou organização *borderline* sem especialização na abordagem), garantindo

segurança e continuidade do cuidado na transição. O grupo tocou ainda na questão espinhosa de o que fazer com profissionais de piores desfechos — reconhecendo a importância de tratar a ineficácia, mas ponderando as barreiras e o risco de rotular pessoas.

A IMAGEM QUE FICA: O CHEF E OS INGREDIENTES

A analogia que amarra o capítulo: o terapeuta é o **chef** e as técnicas são os **ingredientes**. Ingrediente bom nas mãos erradas não vira prato; e o melhor chef sem ingrediente nenhum também não cozinha. Eficácia é a combinação dos dois — e é por isso que o ciclo vai trabalhar a relação *com* rigor técnico, não no lugar dele.

REFERÊNCIAS

- Anderson, T., Ogles, B. M., Patterson, C. L., Lambert, M. J., & Vermeersch, D. A. (2009). Therapist effects: Facilitative interpersonal skills as a predictor of therapist success. *Journal of Clinical Psychology*, 65(7), 755–768.
- Anderson, T., Crowley, M. E. J., Himawan, L., Holmberg, J. K., & Uhlin, B. D. (2016). Therapist facilitative interpersonal skills and training status: A randomized clinical trial on alliance and outcome. *Psychotherapy Research*, 26(5), 511–529.
- Miller, W. R., & Moyers, T. B. (2021). *Effective Psychotherapists: Clinical Skills That Improve Client Outcomes*. New York: Guilford Press. [Cap. 2.]
- Rosenzweig, S. (1936). Some implicit common factors in diverse methods of psychotherapy. *American Journal of Orthopsychiatry*, 6(3), 412–415.
- Moyers, T. B., & Miller, W. R. (2013). Is low therapist empathy toxic? *Psychology of Addictive Behaviors*, 27(3), 878–884.

NOTA DE MÉTODO

Modulei a afirmação de que as habilidades interpessoais seriam "o fator determinante" para o que a literatura de fato sustenta — o preditor mais consistente entre as variáveis do terapeuta, o que não anula o peso da técnica. A menção a pesquisas "desde 1940" foi contextualizada na tradição de fatores comuns (Rosenzweig, 1936) e de efeitos do terapeuta; o estudo dos "23 de áreas diversas" foi ancorado em Anderson et al. (2016). Relatos do grupo foram mantidos de forma genérica, sem expor pacientes.

Levar para a prática

Marque conforme experimentar em sessão — e salve o PDF para acompanhar.

- ☐ Pedi feedback a alguém que atendo — ou gravei uma sessão (com autorização) para me rever.
- ☐ Levei à supervisão o "como" intervir, não só o "o que" fazer.
- ☐ Tolerei o silêncio em vez de preenchê-lo por ansiedade.
- ☐ Li um comportamento difícil como dado clínico, não como ofensa pessoal.
- ☐ Reconheci um limite meu e considerei encaminhar quando faltou habilidade técnica.

MINHAS ANOTAÇÕES — O QUE LEVO PARA A CLÍNICA

Para revisar — responda

Responda com suas palavras. O texto fica salvo no PDF.

1. Por que "ser gentil" não é o mesmo que ser eficaz? O que a pesquisa de efeitos do terapeuta mostra?

2. O que o estudo de Anderson et al. (2016) permite — e o que não permite — concluir sobre formação e eficácia?

3. Diante de um paciente que omite informações, qual é a leitura técnica — e como ela protege a empatia?

4. Em que situação encaminhar é o ato mais ético? Dê um exemplo da sua prática.